Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Dante Alonso Nostroza Barbaran				Sexo	F		M	X
Fecha Nacimiento	5-Julio-2018	Edad actual	años	meses	País natal:			
Domicilio actual:	Villa Bernardo Cruz PJ3 #89				Teléfono	987074664		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende X	habla X	lee	escribe		
Lengua de uso	Chilena	Grado dominio	comprende X	habla X	lee	escribe		
Escolaridad actual:	1 básico	Establecimiento	Liceo Mixto San felipe					

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 08-05-2025.	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Ayling Barbaran	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 08-05-2025	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Paula Delgado Veas	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga PIE.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Dificultad en el aprendizaje.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☒ No ☐ Sí (especificar)

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) PREClamSia.

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO	Peso: 2 950 kl	Talla: 78 cm

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto: PRESION ARTA Durante el enBaRAZO

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No		Vacunas	~~Sí~~	No

Observaciones: Hospitalizacion por Plaquetas Bajas (2 veces)

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 8 meses	Se sienta sólo/a: 9-10 meses	Camina sin apoyo: 1 A 1 MES
Primeras palabras: 2 AÑOS	Primeras frases: 1 AÑO	Se viste solo/a: 4 AÑOS

Controla esfínter vesical Diurno: X Nocturno: X	Controla esfínter anal Diurno: X Nocturno:

Observaciones: Comienza a vestirse solo a los 5 AÑOS, Exepto zapatos. Dificultad para comer solo.
Habla en el segundo Semestre de la escuela de lenguaje.

En su actividad motora general se aprecia: ☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☐ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	Sí	~~No~~	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonrie, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones: Independiente.
Escribe con ambas mano.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí X	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí X	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No X	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí X	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No X	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí X	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí X	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No X
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí X	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí X	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No X	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No X	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No X
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No X	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No X
Observaciones: Acerca mucho las cosas. Cuando hay bulla tiende a tapanse los oidos. le cuesta la pronunciación de palabras					

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma					
X oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí X	No	Emite/produce frases	Sí X	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No X	Relata experiencias	Sí X	No
Emite palabras/produce señas	Sí X	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No X
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí X	No	Sigue instrucciones simples	Sí X	No
Identifica personas	Sí X	No	Sigue instrucciones complejas	Sí X	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No X	Sigue instrucciones grupales	Sí X	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No X	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No X
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):					
Observaciones: SE FRUSTRA cuando NO le entienden. le falta comprensión al preguntarle cosas de la vida diaria. Intenta Relatar experiencias. No comprende cuentos.					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No X	Se relaciona en forma colaborativa	Sí X	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No X	Respeta normas sociales	Sí	No X
Participa en actividades grupales	Sí X	No	Respeta normas escolares	Sí	No X
Opta por trabajo individual	Sí X	No	Muestra sentido del humor	Sí X	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí X	No	Movimientos estereotipados	Sí	No X
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí X	No	Pataletas frecuentes	Sí X	No
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☐ natural ☐ desmesurada		**Sonidos:** ☐ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** ☐ natural ☐ desmesurada	
Observaciones: Selectivo para relacionarse. Pataletas cuando tenia entne 1 a 5 años					

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	X Sí	No	Trastorno motor	Sí	X No
Epilepsia	Sí	X No	Problema bronco-respiratorio	Sí	X No
Problemas cardiacos	Sí	X No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	X No
Paraplejia	Sí	X No	Trastorno emocional	Sí	X No
Pérdida auditiva	Sí	X No	Trastorno conductual	Sí	X No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Derivado a oculista debido a que expresa no ver.

Alimentación: ☐ normal ☒ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☒ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 7 -8 horas

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor	Duerme: ☐ solo ☒ acompañado (Especifique): Abuelo

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☒ alegre ☒ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☒ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones: Cuesta hacerlo Dormir. Buen Humor al Despertar Relativo. Bruxismo. nocturno.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. HUGO Inostroza	Papá	38	MEDIA I	Temporero
2. Ayling Boebaran	mamá	34	U. Comple	Dueña Casa.
3. Vicente Inostroza	Hermano	3me	-	-
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

abuela materna = Diabetes e hipertención, hipotiroide
abuela paterna = Diabetes e hipertención.

Observaciones:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4 años	Asistió a jardín infantil	Sí	X No
Nº de colegios en que ha estudiado		Modalidad de enseñanza Regular X Especial ☐ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios: Ingreso a 1° Básico.				

Ha repetido curso/s	Sí	No X	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	1° A		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No X	**Dificultad para participar**	Sí X	No	**Conducta disruptiva**	Sí	No X
Asiste regularmente	Sí X	No	Asiste con agrado	Sí X	No	Apoyo familiar en tareas	Sí X	No	Amigos (as)	Sí X	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

X satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

X apoyo | castigo | indiferencia | compasión | tensión | otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

X apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☐ expresiones afectivas X alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes X tiempo libre X otro(s)..... celular.....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

X madre X padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☐ alta (incluye al grupo familiar) X mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

X Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Prima Directa Diagnosticada con TEA
- Tomaba medicamentos Vitamina D, Melatonina, 2024.
- asistio a escuela de lenguaje.
- Pocos amigos (2)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY